

ANAMNESE/STATUS/DIFFERENTIALDIAGNOSE

Dr. Gerhard Halmerbauer

E.mail: gerhard.halmerbauer@fh-steyr.at

Anamnese Definition

Die Anamnese (von altgriechisch ἀνάμνησις *anámñēsis*, deutsch ‚Erinnerung‘) ist die professionelle Erfragung von potenziell medizinisch relevanten Informationen durch Fachpersonal (z. B. einen Arzt).

Dabei antwortet entweder der Patient selbst (Eigenanamnese) oder eine dritte Person (Fremdanamnese). Ziel ist dabei meist die Erfassung der Krankengeschichte eines Patienten im Rahmen einer aktuellen Erkrankung.

Die Anamnese ist die wesentliche Grundlage für das Stellen einer Diagnose und ist in allen medizinischen Disziplinen von hoher Bedeutung.

Sie kann Fragen beinhalten z. B. nach Vorerkrankungen und Allergien, familiären Erkrankungen, Beruf, Medikamenteneinnahmen, Risikofaktoren, Sexualverhalten, Reiseverhalten und subjektiven Beschwerden.

Anamnese

Symptome/Schmerzen: Beginn, Lokalisation, Verlauf / Dauer, Einflüsse, die zur Verschlimmerung / Verschlechterung führen, Art / Qualität, Ausprägung / Stärke

Erkrankungen in der Familie:

Informationen über die Verwandten eines Patienten können Aufschlüsse über Erbkrankheiten und Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen bieten. Dies gilt beispielsweise für das gehäufte Auftreten von Tumoren, Allergien, Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychischen Störungen

Anamnese

Kindererkrankungen

Biografische Anamnese: Die gesamte Lebensgeschichte des Patienten wird erfasst. Eine sorgfältige Erhebung schließt biologische, psychische und soziale Fragen ein. Die Informationen, die dabei gewonnen werden, erlauben oftmals Rückschlüsse auf Risikofaktoren und kausale Zusammenhänge

Sozialanamnese: Es soll die soziale Position des Patienten erfasst werden. Gefragt wird unter anderem nach dem Familienstatus, dem Beruf sowie nach der Religionszugehörigkeit.

Frühere Erkrankungen mit Bezug zum Leitsymptom

Von besonderem Interesse sind natürlich frühere Erkrankungen, die in einem mutmaßlichen oder sicheren Zusammenhang mit den aktuellen Beschwerden stehen.

Berichtet ein Patient über zunehmende Luftnot bei Belastung und Beinödeme, so steht ein vor 10 Jahren durchgemachter Herzinfarkt damit wahrscheinlich in ursächlichem Zusammenhang.

Musste sich eine Patientin vor 5 Jahren einer Brustamputation wegen eines Mammakarzinoms unterziehen, so sind die neu aufgetretenen Rückenschmerzen u. a. verdächtig auf eine Metastasierung in die Wirbelsäule.

Auch psychische Symptome müssen beachtet werden!



Beispiele spezifischer Fragen an Hand des Symptoms „Beinschwellung“

Beispiele spezifischer Fragen an Hand des Symptoms „Beinschwellung“:

1. Lokalisation und Ausbreitung

- Wie sehen die Schwellungen aus?
 - Betreffen sie beide Beine?
 - Sind beide Beine gleich stark betroffen?
 - Wo genau treten die Schwellungen auf?
 - Sind sie nur auf die Knöchelregion begrenzt?
 - Reichen sie weiter hinauf?
 - Ist der Fußrücken mit betroffen?
-

2. Qualität

- Wie fühlen sich die Schwellungen an?
 - Machen Ihnen die Schwellungen irgendwelche Beschwerden?
 - Sind die Schwellungen schmerzhaft?
 - Bis wohin gehen die Schmerzen, wohin strahlen sie aus?
 - Wo genau verspüren Sie das Druckgefühl?
 - Sind die Schwellungen eher weich oder eher derb?
-

3. Schweregrad

- Sind die Schwellungen sichtbar?
 - Sind sie sehr ausgeprägt?
 - Sind sie nur nachweisbar, wenn man hindrückt?
 - Hinterlassen die Socken oder Strümpfe eine Einkerbung?
 - Werden die Schuhe zu eng?
-

4. Zeitliches Auftreten

- Wann haben Sie die Schwellungen zum ersten Mal bemerkt?
 - Sind die Beschwerden seither konstant?
 - Sind die Schwellungen zwischenzeitlich einmal ganz verschwunden?
 - Gibt es Gründe hierfür?
 - Hatten Sie früher schon einmal ähnliche Beschwerden?
-

5. Verstärkung/Abschwächung des Symptoms

- Wann sind die Schwellungen besonders ausgeprägt?
 - Gibt es tageszeitliche Schwankungen?
 - Haben Sie einen „stehenden“ Beruf?
 - Spielen die Nahrungsaufnahme oder das Trinken eine Rolle?
 - Wie ist es, wenn Sie sich hinlegen oder die Beine hochlagern?
 - Haben Sie irgendwelche Medikamente genommen?
 - Haben die Medikamente geholfen?
-

6. Begleitsymptomatik/7. Grad der Behinderung

- Haben Sie noch weitere Beschwerden?
 - Haben Sie an Gewicht zugenommen?
 - Haben Sie Wadenkrämpfe?
 - Haben Sie Atemnot oder Herzbeschwerden?
 - Müssen Sie nachts zum Wasserlassen aufstehen?/Ist Ihnen am Urin etwas aufgefallen?
 - Wie stark sind Sie durch die Schwellungen beeinträchtigt?
 - Können Sie Ihren Beruf ungehindert ausüben?
 - Haben Sie Probleme am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Familie, im Bekanntenkreis?
-

Status: Atemwege

Status

- Schleimhaut (Mundhöhle, Konjunktiven): rosig - gut durchblutet - livide – zyanotisch
 - Thorax: Glocken-, Faßthorax; Trichterbrust u.a.
 - Husten: trocken - produktiv; stakkatoartig - bellend – röhrend
 - Atmung: durch Nase oder Mund
 - Atemfrequenz: Neugeborene: 60 - 40; 1 - 9 J.: 30 - 20; 10 - 14 J.: 20 - 14/min
 - Atemtyp, Atemexkursionen: flach, tief, unregelmäßig, Schnappatmung u.a.
 - Atemrhythmus (Ein-/Ausatmung), altersentsprechend: Säugling ca. 1:1; Schulkind ca. 1:2; Erwachsener 1:2,5 bis 1:3
 - Zyanosekomplexzeichen: Uhrglasnägel, Trommelschlegelfinger, -zehen
-

Status

- **Atemgeräusch(e)** bei spontaner - vertiefter - forcierter Atmung;
in welcher Phase des Atemzyklus: früh-, spätinspiratorisch; früh-, spätexpiratorisch

Ohne Stethoskop:

- Husten produktiv/nicht produktiv, trocken ("Reizhusten");
 - expiratorisches Stöhnen ("Knorksen");
 - deutlich verlängertes Expirium (Ausatmen)
 - Stridor (in-/expiratorisch); "Karcheln": inspiratorischer Stridor und expiratorisches Röcheln;
 - *Ursprungsort der Geräusche:* Nase, Mund, Epipharynx, Larynx, tiefe Atemwege
-

Status

Mit Stethoskop

- **feuchte Rasselgeräusche:** grobblasig (fortgeleitet ?) - mittelblasig - feinblasig (Crepitationes; "klingend" ? "klettverschlussartig" ?)
 - **trockene Atemgeräusche oder Nebengeräusche:** (Giemen, Brummen, Pfeifen, Reiben, Quietschen)
 - **Atemarbeit:** expiratorisch: Bauch-, Atemhilfsmuskulatur; inspiratorisch: Nasenflügelatmen, thorakale Einziehungen (jugulär, intercostal, epigastrisch, sternal)
 - **Perkussion:** (1-Finger-Technik): primär vergleichend; gezielt abgrenzend): Klopfeschall sonor - hypersonor - gedämpft (verkürzt) - tympanitisch
-

Beispiele für Infektionserkrankungen

DIFFERENTIALDIAGNOSE

Rhinitis



Bellender Husten



Halslymphknoten- schwellung



Konjunktivitis





1 Koplik-Flecken bei Masern
= Enanthem am Gaumen



5 Konfluierendes Masernexanthem



10 Häorrhagische Masern

Masern

Erreger: Paramyxovirus; fliegende Infektion (per Aerosol)

Epidemiologie: Weltweit sterben > 1 Million Kinder jährlich an Masern (insbesondere in armen Ländern)/Hoher Kontagionsindex – hoher Immunitätsgrad nach durchgemachter Infektion (lebenslange Immunität)

Typische Kinderkrankheit/Säuglinge bis 8 Monate erkranken nicht wenn Mutter Masern durchgemacht hat

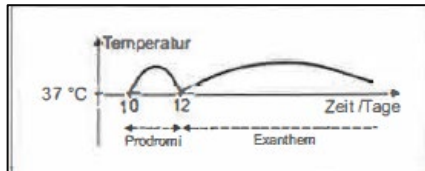
Inkubationszeit: Erst Beginn der Prodromi; 11 Tage bis zum Ausbruch des Exanthems

Infektiosität: Beginnt mit Symptomatik und endet 4 Tage nach Exanthemausbruch

Masern - klinisches Bild

Rhinitis, Konjunktivitis, hohes Fieber, Bellender Husten, Lichtscheu, gedunsenes Gesicht, Enanthem am Gaumen, Koplik`kalkspritzerartige Flecken an der Wangenschleimhaut gegenüber den Molaren

Exanthem: Großfleckig, konfluierend Beginn hinter den Ohren, kraniokaudale Ausbreitung, später feine Schuppung; mit Exanthembeginn erneuter Fieberanstieg
Halslymphknoten-Schwellung gelegentlich Bauchschmerzen



Untersuchungen

Labor: Verminderung von Leukozyten, Lymphozyten, Eosinophilen, passagere Thrombozytopenien

DD: Bei Teilimmunität ist das Exanthem nur diskret (mitigierte Masern)

Nachweis von IgM-Ak oder Virus-RNA bei frischer Infektion (oder Titeranstieg in 2. Probe)

Bei Masernenzephalitis Virusnachweis (mittels PCR) im Liquor. Bei SSPE hoher Ak-Titer im Liquor (Virustest i.d.R. negativ)

THERAPIE

Symptomatisch; Ev. Antibiotika bei bakterieller Superinfektion

Bei Immunsupprimierten evtl. Therapieversuch mit Ribavirin
Zulassung zu Gemeinschaftseinrichtungen frühestens 5 Tage nach
Ausbruch des Exanthems.

Empfängliche (ungeimpfte) Kontaktpersonen in Wohngemeinschaft
mit Masernkranken werden 14 Tage von
Gemeinschaftseinrichtungen ausgeschlossen.

KOMPLIKATIONEN:

Mittelohrentzündung (=bakterielle Superinfektion)

Masernpneumonie:

- Virale Masernpneumonie

- Bakterielle Superinfektion

Masernenzephalitis (nach 2 Tagen bis 2 Wochen 1:2000 Masernkranke die älter als 1 Jahr sind mit einer Letalität von 20 Prozent!!!!; Defektheilung bei weiteren 20 Prozent: Intelligenzminderung, Epilepsie)

Laryngotracheitis mit Krupp (Erstickungsgefahr!) Subakute sklerosierende Panenzephalitis nach 6-8 Jahren: letal; Vorkommen 1: 200.000)

Foudroyanter Verlauf (selten): letal durch Kreislaufversagen

Prophylaxe I

Aktive Immunisierung (Impfung mit abgeschwächter Lebendvakzine):

Ind: 1. Erstimpfung für Kinder mit 11 -14 Monaten (z.B. Im Rahmen einer MMR-Vakzination gegen Masern, Mumps und Röteln) mit Wiederholung nach 4 Wochen. Schließung von Impflücken auch nach dem 18. Lebensjahr - Masern-Eradikationsziel der WHO (durch weltweite und nationale Impfprogramme). Seronegative Beschäftigte mit erhöhtem Infektionsrisiko (im Gesundheitsdienst und bei der Betreuung von Immundefizienten und in Gemeinschaftseinrichtungen)

Prophylaxe II

Post-expositionelle Impfung innerhalb von 3 Tagen nach Exposition bei nicht geimpften, immungesunden Kontaktpersonen.

Nebenwirkungen: Im Abstand von 5-14 Tagen nach der Impfung leichte Impfmasern" bei bis zu 5 % der Geimpften (nicht ansteckend). Selten: Fieberkrampf oder allergische Reaktionen.

Passive Immunisierung mit humanem Immunglobulin (z.B. Privigen®) bei abwehrgeschwächten Patienten: Wirksam innerhalb 2- 6 Tage nach Masernexposition; zwischen 4. - 7. Krankheitstag evtl. milderer (abgeschwächter) Krankheitsverlauf.

Masernenzephalitis



Röteln

Erreger: Das Rötelnvirus ist ein zur Familie der Togaviren gehörendes RNA-Virus.

Epidemiologie: Vorkommen nur beim Menschen. Übertragung durch nasopharyngeale Sekrete (Tröpfcheninfektion), **diaplazentar**.

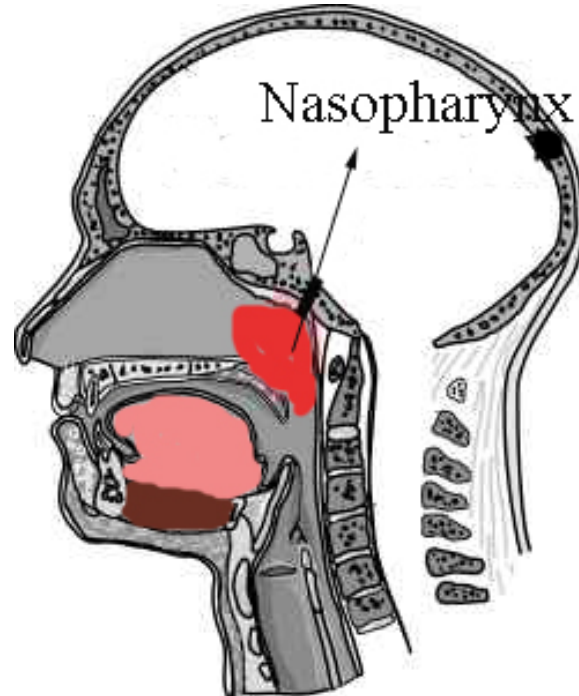
Eine Infektiosität besteht 7 Tage vor bis 7 Tage nach Ausbruch des Exanthems.

Inkubationszeit: 2 - 3 Wochen

Infektiosität: 1 Woche vor bis 1 Woche nach Exanthembeginn

Auftreten von Epidemien meist im Winter und Frühling. Die Inkubationszeit beträgt 2-3 Wochen.

Nasopharynx



Klinisches Bild:

Prodromal-Stadium:

Gelegentlich finden sich leichte grippeartige Prodromi. Die Symptome sind allerdings oft wenig charakteristisch, sodass sich differentialdiagnostisch Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zu anderen exanthematischen Erkrankungen ergeben können.

Exanthem-Stadium: Der diskrete makulöse oder makulopapulöse Ausschlag beginnt im Gesicht und breitet sich dann über Körper und Extremitäten aus. Mittelfleckig: Die Größe der Flecken liegt zwischen Masernexanthem (grob fleckig) und Scharlach (stecknadelgroß). Meist ist er nach 1-3 Tagen wieder verschwunden.

Klinisches Bild:

Nicht konfluierend. Häufig finden sich Lymphknotenschwellungen okzipital (bedeutet "in Richtung Hinterhaupt" bzw. "am Hinterhaupt gelegen,") und retroaurikulär (bedeutet "hinter dem Ohr"; „Ist im Dunkeln diagnostizierbar“). Milzvergrößerung in 50% der Fälle.

Das Krankheitsgefühl ist gering, oft besteht kein Fieber. Vor allem bei weiblichen Jugendlichen und Erwachsenen kann es zum Auftreten flüchtiger Arthralgien (Schmerzen in den Gelenken) kommen.

Komplikationen

Röteln-Enzephalitis (Frequenz 1 : 6000 Erkrankungen) Röteln-Purpura durch passagere Thrombozytopenie (günstige Prognose); Röteln-Arthritis (bei Erwachsenen, günstige Prognose)

Röteln in der Schwangerschaft: Durch diaplazentare Übertragung einer Röteln-Infektion bei einer werdenden Mutter in den ersten Wochen der Schwangerschaft kann es zu Abort, Frühgeburtlichkeit und konnatalen Röteln mit all den gefürchteten Schädigungen des Gehirns, des Herzens, der Augen und des Ohres kommen (siehe Rötelnembryopathie).

Bei einer Infektion im ersten Trimenon liegt das Risiko von Abort, Totgeburt oder einer Fehlbildung bei ca. 85%. Aber auch Infektionen nach dem vierten Schwangerschaftsmonat können zu Mikrozephalie und Schwerhörigkeit führen.

Rötelnembryopathie:

(Gregg-Syndrom = congenital rubella syndrome CRS)

Organschäden: Auge: 70 % (Retinopathie, Katarakt. selten Glaukom); Ohr: 60 % (Taubheit); Herz: 50 % (offener Ductus Botalli, Septumdefekte, Pulmonalstenose); zerebrale Schäden und geistige Retardierung: 45 %; Wachstumsstörung, vermindertes Geburtsgewicht: 75 %

Risiko im ersten Schwangerschaftstrimenon am größten: 1. - 6. Schwangerschaftswoche (SSW): 55 %; 7. - 12. SSW: 25 %; 13. - 17. SSW: 15 -10 %; > 17. SSW i.d.R. keine kindlichen Schäden.

PURPURA



Purpura sind kleinfleckige Kapillarblutungen in der Haut, Unterhaut oder den Schleimhäuten. Die einzelnen Blutungen können punktförmig, kleinflächig oder flächenhaft sein).

Mikrozephalie



Feinfleckiges Rötelnexanthem



Feinfleckiges Rötelnexanthem



Lymphknotenvergrößerung bei Röteln



Scharlach

Erreger: Streptokokkus Pyogenes = β -hämolysierende Streptokokken der Gruppe A

Epidemiologie: Häufigkeitsgipfel: 3.-10. Lebensjahr. Auftreten in
Gemeinschaftseinrichtungen; jahreszeitlicher Gipfel: Oktober-März

Infektion: Tröpfcheninfektion, selten durch Eiter, kontaminierte Milch oder
Gegenstände u.a.

Inkubationszeit: 2-7 Tage; Infektiosität: Endet im Regelfall 24h nach Beginn einer
Antibiotikatherapie

Immunisierung

Streptokokkeninfektionen führen primär zu einer Lokalinfection und hinterlassen daher keine antibakterielle sondern nur eine antitoxische Immunität gegen das erythrogene Toxin (= pyrogene Endotoxine A und C).

Das Vorhandensein verschiedener erythrogener Toxine erklärt auch das Auftreten einer Zweiterkrankung an Scharlach (1 - 4 % d.F.).

Scharlach - klinisches Bild (Symptomatik)

Plötzlicher, stürmischer Beginn mit Halsschmerzen, Husten, Erbrechen, hohes Fieber, Kopf und Leibschmerzen, Tachykardie (erhöhte Herzfrequenz)

Pharyngitis (Eine Rachenentzündung ist eine Entzündung der Rachenschleimhaut. Sie tritt als Begleiterscheinung von entzündlichen Prozessen im Hals-Rachenbereich in Erscheinung. Die mit ihr verbundenen Halsschmerzen und Schluckbeschwerden erschweren die Nahrungsaufnahme drastisch).

Pharyngitis



Pharyngitis



Scharlach - klinisches Bild (Symptomatik)

Angina Tonsillaris mit Enanthem (auch an der Uvula), Schwellung der Halslymphknoten

Als Tonsillitis oder Mandelentzündung bezeichnet man eine schmerzhafte Entzündung der Gaumenmandeln (Tonsilla palatina)

Zunge anfangs belegt, ab 4. Tag Himbeerzunge

Angina Tonsillaris



Himbeerzunge



Scharlach - klinisches Bild (Symptomatik)

Ab 2. oder 3. Tag Auftreten eines Exanthems: Stecknadelgroß, beginnend im Bereich von Achseln, Leisten und aufsteigend in Richtung Hals, intensive Wangenrötung, nach 2-4 Wochen Hautschuppung an Handinnenflächen und Fußsohlen

Rumpel-Leede positiv (Auftreten von Petechien am Unterarm nach Aufpumpen der Blutdruckmanschette 5 Minuten oberhalb diastolischer Druck)

Scharlach Exanthem



Komplikationen

Toxischer Verlauf: Erbrechen, Durchfälle, Kreislaufversagen (Herzmuskelentzündung!), Krämpfe, Benommenheit

Mandelentzündung (ulzerierend!), Stirnhöhlenentzündung (Sinusitis),

Mittelohrentzündung (Otitis Media)

Septischer Verlauf, Meningitis (Hirnhautentzündung)

Streptokokkenallergische Nacherkrankungen: Rheumatisches Fieber (Herzbeteiligung!), rheumatische Karditis, akute Glomerulonephritis

Therapie

Therapie: Antibiotika

Prophylaxe:

Expositionsprophylaxe mit Penicillin bei Personen mit engem Kontakt zu Erkrankten.
Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen 48h nach Beginn der Antibiotikagabe.

Frühzeitige und ausreichend lange (10 Tage) Antibiotikatherapie ist die beste Prophylaxe gegen rheumatische Karditis. Eine Poststreptokokken-Glomerulonephritis kann dadurch jedoch nicht immer verhindert werden.

DIFFERENTIALDIAGNOSE

	Scharlach	Masern	Röteln
Beginn	Hohes Fieber Halsentzündung	Hohes Fieber Starker Husten Ev. Halsentzündung	Mäßiges Fieber Leichtes Krankheitsbild
Exanthem	Feinfleckiger Ausschlag von unten nach oben (Mund Kinn Dreieck frei)	Grobfleckiger <u>konfluierender</u> Ausschlag von oben nach unten (beginn retroaurikulär)	Nur schwaches <u>nichtkonfluieren</u> <u>des Exanthem</u> an Hals/Brust
Besonderes	Himbeerzunge	Koplik'scher Wangenfleck	Starke nuchale Lymphknotensch wellung

Zusammenfassung:

Vergleich zwischen „gesund“ und „krank“ (Physiologie vs. Pathologie) führt zur Identifikation von „Symptomen“.

Verschiedene Symptome gemeinsam ergeben ein Krankheitsbild.

Symptome können durch Schilderung der PatientInnen (Befragung, Anamnese), durch körperliche Untersuchung (Status) oder weiterführende Diagnostik in Erfahrung gebracht werden.

Unter Differentialdiagnose versteht man die Abgrenzung von ähnlichen Krankheitsbildern „**Leitsymptome**“ weisen den Weg zur eindeutigen Zuordnung der Erkrankung.
